



Propuesta de Investigación Formativa

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Conclusiones

1. La vocación no debe ser una excusa para el desgaste

A lo largo de la investigación, se hace evidente que la "normalización cultural" ha llevado a creer que el cansancio extremo es parte del "paquete" de ser auxiliar de enfermería. Hemos concluido que la institución y la sociedad a menudo disfrazan la sobrecarga como una "prueba de vocación", lo que es un error peligroso. No se puede esperar que un profesional cuide con calidad si el sistema lo obliga a trabajar en condiciones que agotan su propia humanidad; la vocación debe ser apoyada por el sistema, no explotada por él.

2. El cansancio no discrimina experiencia

Un hallazgo humano muy potente es que tener 6 años de experiencia promedio no hace que el trabajador sea "inmune" al agotamiento. Al contrario, se concluye que el personal con trayectoria es el que más sufre el peso de la sobrecarga acumulada. Esto nos dice que la fatiga no es un problema de falta de capacidad del auxiliar, sino un resultado directo de turnos de 12 horas y horas extras constantes que terminan por romper incluso al personal más preparado y resiliente.

3. El paciente recibe las consecuencias de un sistema agotado

La investigación permite concluir que cuando un auxiliar está sobrecargado, el paciente deja de ser visto como una persona y pasa a ser visto como una "tarea más" en una lista interminable. La falta de tiempo obliga al personal a elegir entre cumplir con el medicamento o brindar una palabra de aliento, y casi siempre la carga administrativa gana. Esto significa que la sobrecarga laboral no es solo un problema de nómina o de horarios, sino un obstáculo real para la recuperación humana de los enfermos.

4. La necesidad urgente de cuidar al que nos cuida

Finalmente, se concluye que el modelo de "supervivencia" donde el auxiliar debe resolver sus problemas emocionales solo, ya no es sostenible. Los datos muestran que el personal está llegando al límite de su salud mental y física, experimentando ansiedad e insomnio. Es imperativo pasar de los aplausos y el reconocimiento vacío a acciones reales: turnos justos, pausas de descanso obligatorias y un soporte institucional que entienda que para tener pacientes sanos, primero necesitamos tener cuidadores sanos y descansados.